

PLANILLA DE SUSPENSIÓN DE WARFARINA

SIN PUENTE DE ENOXAPARINA

Uso individual – completar según fecha operatoria, dosis y criterio médico



Paciente:		Médico:	
DNI:		INR previo:	
Procedimiento:		Riesgo trombótico:	Bajo / Intermedio / Alto ▼
Fecha de cirugía:		Observaciones:	

PLAN DE SUSPENSIÓN Y REINICIO (SIN PUENTE)

Día -6	Día -5	Día -4	Día -4	Día -3	Día -2	Día 0	Día +1	Día +2 a +4	Día +5 o según INR
 Evaluación inicial - Controlar INR. - Evaluar riesgo trombótico y hemorrágico. - Planificar suspensión según tipo de procedimiento.	 Suspender warfarina - Última dosis de warfarina (idealmente hace ≥ 5 días de la cirugía). - No administrar más warfarina.	 Sin warfarina - No administrar warfarina. - Controlar INR si se considera necesario.	 Sin warfarina - No administrar warfarina. - Controlar INR si se considera necesario.	 Sin warfarina - No administrar warfarina. - Considerar control de INR (preoperatorio) según indicación.	 Sin warfarina - No administrar warfarina. - Evaluar INR preoperatorio según indicación del equipo tratante.	 Cirugía / Quirófano - No administrar warfarina. - Procedimiento según equipo tratante.	 Reiniciar warfarina - Reiniciar warfarina cuando exista hemostasia adecuada. - Habitualmente 12–24 h después de la cirugía según indicación del equipo tratante.	 Continuar warfarina - Dosis habitual según indicación. - Controlar INR y ajustar dosis según resultado.	 Continuar warfarina - Mantener warfarina. - Controlar INR hasta alcanzar rango terapéutico (2,0–3,0) según indicación.
Dosis / Hora:	Dosis / Hora:	Dosis / Hora:	Dosis / Hora:	Dosis / Hora:	Dosis / Hora:	Dosis / Hora:	Dosis / Hora:	Dosis / Hora:	Dosis / Hora:



Consideraciones importantes

- Suspender warfarina al menos 5 días antes de la cirugía (algunos pacientes pueden requerir 6 días o más).
- No se requiere enoxaparina en la mayoría de los pacientes.
- Controlar INR previo al procedimiento (idealmente $< 1,5$).
- Reiniciar warfarina 12–24 h post cirugía según hemostasia.
- Ajustar dosis según INR.
- Coordinar con equipo quirúrgico y anestesia.



Recordatorio:

Individualizar la conducta según riesgo trombótico, riesgo hemorrágico, función renal y tipo de procedimiento.



Consultorio GHEMAS
Arrieta 1728,
Villa Luzuriaga



Consultorio Baruch
Agüero 1235,
Morón



Turnos / WhatsApp:
11 5403 0229



Fuentes y referencias

- Douketis JD, et al. Perioperative Management of Antithrombotic Therapy. CHEST. 2022.
- Sociedad Argentina de Hematología. Guías de Diagnóstico y Tratamiento. Hemostasia y Trombosis. 2023.

Adaptar siempre al paciente, al procedimiento y al criterio del equipo tratante.